

SITREP N°01

SGI MVE

Date de publication
04 Septembre 2025

Rapport journalier de l'épidémie de MVE en RDC

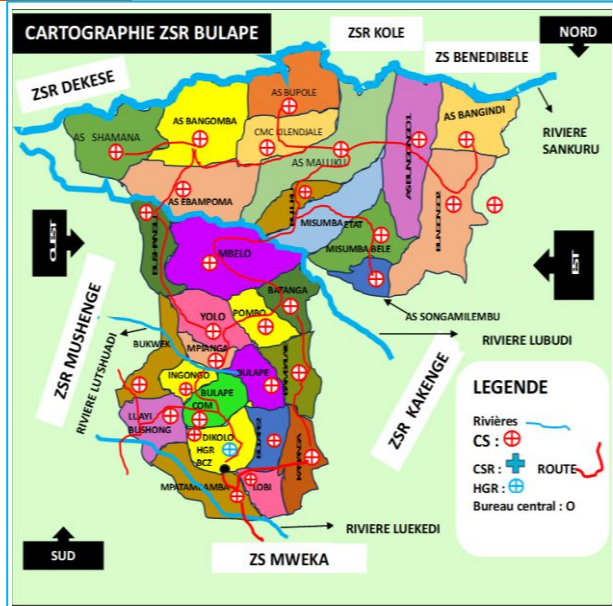
Données du 04 Septembre 2025

Semaine épidémiologique 36

Historique de la situation

- En date du **20/08/2025**, le service de gynéco-obstétrique, a reçu une parturiente du nom de MBULU PEMBI, âgée de 34 ans, et porteuse d'une grossesse de 34 semaines d'aménorrhée avec comme plaintes : Fièvre, émission des selles liquides teintées du sang.
- Il s'en est suivi une diarrhée sanguinolente (méléna), des vomissements sanglants (hématémèses), une hémorragie nasale (épistaxis), et une anémie.
- Quelques heures après son admission, elle a fait un arrêt cardiorespiratoire dans un tableau de défaillance multi viscérale.
- Quatre jours après, le technicien de laboratoire ayant manipulé ses sécrétions, a manifesté les mêmes signes et est décédé.
- Une semaine après, l'infirmière l'ayant reçu et soigné, a manifesté les mêmes signes et est décédée ce matin du **01/09/2025**, dans le même tableau.

Dans un écart d'une semaine, soit de la S34 à la S36, l'on a enregistré 8 décès, tous présentant les mêmes signes et décédés dans le même tableau. Le total des cas notifié est de 13 cas dont 8 décès, soit une létalité de 62%



COMMENTAIRES :

- ⊗ **NORD** : Elle est limitée par la rivière SANKURU qui nous sépare de la ZS DEKESE, KOLE et BENEDIBELE
- ⊗ **SUD** : Par la rivière LWEKEDI qui nous sépare avec la ZS de MWEKA
- ⊗ **EST** : Par le bosquet d'ITAPANYI qui fait notre limite avec la ZS de KAKENGE
- ⊗ **OUEST** : Par le bosquet de MASHANA qui fait notre limite avec la ZS de MUSHENGE
- ⊗ **Superficie** : 4533 km²
- ⊗ **Population totale** : 350112 Hab.
- ⊗ **Densité** : 54 hab. / km²

Fig. 1. Cartographie de la zone de santé de BULAPE

Situation épidémiologique

Total Cas suspects province : 28

- ZS Bulape : 27
- ZS Mweka : 1

Total Décès province : 15 (létalité de 53,6%)

- ZS Bulape : 14 (létalité de 51,9%)
- ZS Mweka : 1 (létalité de 100%)

Distribution par semaine épidémiologique :

- **Semaine 34** : 5 cas
- **Semaine 35** : 6 cas
- **Semaine 36** : 17 cas

Tendance à l'augmentation du nombre de cas suspects, avec un pic en semaine 36.

Actions de réponse

1. Coordination au niveau national

- Réunion d'activation du COUSP
- Déploiement en cascade de l'Équipe d'Intervention Rapide (EIR) vers l'épicentre
- Réunion de déclaration officielle (point de presse du ministre)
- Présentation du plan de réponse – Vendredi à 10h00 pour mobilisation des ressources
- Télé briefing des ECZ dans l'organisation de la réponse locale

➤ Coordination au niveau opérationnelle

- Installation de comité de crise multisectoriel Provincial sous la présidence de Gouverneur de Province ,
- Installation de SGI Provinciale sous la présidence de CD avec les responsables de toutes les sections ,
- Installation de SGI au niveau de la ZS de Bulape et les ZS voisines,
- Tenue des réunions,
- Arrivée de l'EIR nationale à Tshikapa (03/09/2025)
- Actualisation du plan de communication ;

2. Surveillance :

- Collecte et compilation des données;
- Participation au télé briefing des opérations COUSP (niveau central sur l'organisation locale de la réponse);
- Réunion de surveillance avec les PTF;
- Harmonisation des données et listage des contacts
- Recherche active des cas et suivi des contacts.
- Partage des outils de surveillance ;
- Investigation des alertes ;
- Renforcement de la surveillance à base communautaire (ReCo)

Défis

- Faible activité dans le listage et suivi des contacts ;
- Pas d'appui nutritionnel, alimentaire et psychosocial aux malades, de leurs familles et du personnel médical ;
- Pas de CTE normé
- Pas de moyen d'évacuation des malades Communautaire
- Faible activité de recherche active des cas

3. PCI-EHA

- Organisation d'un EDS dans la limite de la biosécurité.
- Evacuation des matelas sans cuire de protection.

4. CREC

- Organisation des séances de sensibilisation (émissions dans les media, ...)
- Elaboration des messages de sensibilisation

5. Laboratoire

- Prélèvement des échantillons et expédition à l'INRB Kinshasa (en attente des résultats)
- Arrivée d'un laboratoire mobile INRB à Tshikapa (03/09/2025) en route vers Bulape
- Rendu des résultats des analyses réalisées par l'INRB
- Prélèvement des échantillons et expédition de 6 échantillons à Tshikapa

6. PEC Holistique :

- Récolte et compilation des données ;
- Elaboration de ;a stratégie de fonctionnement du pilier PEC HOLISTIQUE ;
- Prise en charge médicale
- Isolement des cas suspects

Recommandations

- **Renforcer le système de listage et de suivi des contacts**
Mettre en place une stratégie structurée de suivi des contacts, incluant des outils harmonisés, une formation ciblée, et un mécanisme de supervision régulière.
- **Intégrer un appui nutritionnel, alimentaire et psychosocial**
Développer un paquet d'assistance multisectorielle pour les malades, leurs familles et le personnel médical, incluant des rations alimentaires adaptées, un soutien nutritionnel spécifique, et des interventions psychosociales contextualisées.
- **Mettre en place un Centre de Traitement EBOLA (CTE) conforme aux normes**
Identifier un site approprié et mobiliser les ressources nécessaires pour établir un CTE répondant aux standards nationaux, avec des protocoles clairs et du personnel formé.
- **Développer un mécanisme communautaire d'évacuation des malades**
Élaborer un système d'évacuation communautaire sécurisé et accessible, en collaboration avec les leaders locaux et les structures de santé de proximité.
- **Intensifier la recherche active des cas**
Déployer des équipes mobiles et des stratégies de dépistage ciblé dans les zones à risque, en intégrant les relais communautaires et les données de surveillance pour orienter les interventions.

Quelques photos d'action



Conférence de Presse de la déclaration de la 16^{ème} épidémie MVE en RDC



Elaboration du PAI MVE MWEKA



Présentation de l'état d'avancement du PAI MVE MWEKA



Activités minimalistes de la Prévention et contrôle des infections à l'HGR MWEKA

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter :
Pour l'Institut National de la Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP
Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné
Tel. : +243 816 040 145

E-mail : dieudonnmwambakazadi@gmail.com

Le Coordonnateur COU-SP
Prof NGANDU Christian
Tél. : +243998091915
E-mail : nganduchristian@ymail.com

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Le Représentant de l'OMS en RDC :

Dr HAMA SAMBO Boureima

E-mail : sambob@who.int

Le Team Lead Cluster EPR de l'OMS en RDC :

Dr Mouctar Diallo

E-mail : dialloam@who.int



Système de Gestion incident MVE

